Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
4ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo

Av. Unisinos, 99 - Bairro: São João Batista - CEP: 93022414 - Fone: (51) 3098-5794 - Balcão Virtual (Whatsapp): 51 99602.8034 - Email: frsaoleo4vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5017508-70.2024.8.21.0033/RS

AUTOR: JANE FERRAZ GOMES

RÉU: UNIMED VALE DO SINOS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos.

JANE FERRAZ GOMES ajuizou **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES** contra **UNIMED VALE DO SINOS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA**, partes qualificadas nos autos (evento 1, INIC1). Informou ser beneficiária de plano de saúde da ré. Mencionou que em 26 de abril de 2024 sofreu uma queda e lesionou a vértebra L4. Aduziu que foi diagnosticada com osteoporose e teve prescrito tratamento com o medicamento Prolia 60 mg, de 6 em 6 meses. Informou que a ré negou-se a fornecer o tratamento na esfera administrativa. Pontuou que interpôs recurso administrativo, mas a ré manteve a negativa. Afirmou que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não é taxativo. Asseverou que o medicamento pleiteado é de uso ambulatorial (não domiciliar). Aludiu necessidade de fornecimento do fármaco para a continuidade do tratamento. Manifestou-se pela restituição de R$ 840,67, despendidos na compra de uma dose da medicação. Pediu, liminarmente, a determinação de fornecimento da medicação, medida a ser tornada definitiva ao final, com a procedência dos pedidos para obrigar a ré a fornecer a medicação enquanto perdurar a necessidade, além de condená-la ao ressarcimento de R$ 840,67. Postulou o benefício da assistência judiciária gratuita. Instruiu a inicial com documentos.

Foi deferida a liminar (evento 3, DESPADEC1) e concedida a gratuidade de justiça (evento 8, DESPADEC1).

A ré foi citada (evento 11, CERTGM1). Deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação (evento 12).

Foi decretada a revelia da ré e instada a parte autora a dizer sobre provas (evento 17, DESPADEC1).

Houve manifestação de ciência com renúncia ao prazo (evento 20).

Relatei. Passo a decidir.

O processo está apto para julgamento, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC, em razão da revelia da parte ré.

Não há controvérsia sobre a condição da autora de contratante de plano de saúde da ré. Além da revelia da ré, a negativa de autorização juntada no evento 1, OUT15 indica que a autora é beneficiária do contrato 00558980000776017, plano JRS2, ou seja, plano coletivo empresarial que confere cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (evento 1, CONTR6). O documento ainda denota que a negativa de fornecimento decorreu do fato de entender a ré que o medicamento era para uso domiciliar e fora do meio de internação hospitalar:

> A ANS determina cobertura obrigatória pelos planos de saúde, para aqueles tratamentos elencados no Rol de Procedimentos e Eventos e **desde que preenchidos os critérios estabelecidos por meio de Diretriz de Utilização**, conforme determina o artigo 3º, inciso II da RN 465/2021.
>
> De acordo com a normatização vigente, a cobertura de medicamentos a usuários de planos privados de assistência à saúde é regulamentada pela Lei n.º 9.656/1998, que no seu art. 12, inciso II, alínea d, prevê **a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos, conforme prescrição do médico assistente, administrados durante o período de internação hospitalar** e faculta no art. 10º, inciso VI, a exclusão de cobertura ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais para tratamento do câncer e para os medicamentos para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos (Lei 9.656/1998, art. 12, inciso I, alínea "c", e inciso II, alínea "g"), o que não é o caso da requerente.
>
> O medicamento solicitado, por sua vez, além de não se enquadrar naquele gênero, é utilizado em domicílio. Some-se a isso que V.Sa. tampouco se encontra em meio à internação hospitalar.
>
> Nesse sentido, importante destacar que apesar de o medicamento ser aplicado via subcutânea, não se trata de medicamento de uso exclusivo em estabelecimento de saúde ou ambulatório, nem que necessite de supervisão de profissional técnico, podendo o próprio paciente, após a leitura das instruções, fazer a auto aplicação.

O contrato dos autos se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo. O entendimento é inclusive sumulado pelo STJ (Súmula 608: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão").

Embora não haja expressa referência ao CID nos laudos do evento 1, OUT12, há indicação de que a parte precisa de tratamento para osteoporose. Além da revelia da parte ré, a resposta do evento 1, OUT15 denota que inexiste controvérsia sobre a doença de que está acometida a autora ter tratamento coberto pelo plano de saúde contratado (art. 10, *caput*, da Lei n.º 9.656/98).

Não é possível à prestadora de saúde limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde da contratante e seus dependentes (consumidores). Deve ser aplicada a interpretação mais favorável à autora, não se admitindo a negativa de cobertura quando inexiste óbice para o seu oferecimento.

Conforme destacado na decisão que deferiu a tutela de urgência, da bula do medicamento postulado depreende-se que deve ser aplicado por profissional de saúde treinado em técnicas de injeção, não podendo ser administrado pelo próprio paciente em ambiente domiciliar. Portanto, se trata de medicamento de uso ambulatorial e deve ser oferecido o tratamento pela operadora do plano de saúde.

Sobre o assunto, segue decisão do STJ:

> *AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. MEDICAMENTO INJETÁVEL.*
> *1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação do art. 1.022 do CPC.*
> *2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Precedentes.*
> *3. **Hipótese em que o medicamento é injetável subcutâneo. "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)." (AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)***
> *Agravo interno improvido.*
> *(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.108.874/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (grifei)*

Prospera ainda o pedido de ressarcimento de R$ 840,67 despendidos para a aquisição da medicação (evento 1, NFISCAL16). Isso porque o valor teve que ser desembolsado em razão da indevida negativa de fornecimento do tratamento pela ré (evento 1, OUT13 e evento 1, OUT15).

Sobre o assunto, segue ementa de julgado proferido em caso semelhante:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TROMBOFILIA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO ENOXAPARINA. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3º, § 2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei nº 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10. Veja-se que é facultado aos planos de saúde estabelecer para quais patologias irão oferecer cobertura; no entanto, não podem limitar o tratamento, pois este cabe somente ao médico assistente do paciente segurado, conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico. Precedentes do e. STJ e desta c. Câmara Cível. Se há previsão de cobertura para a doença do segurado, não faz sentido falar em ausência de cobertura contratual para o tratamento indicado pelo médico assistente, sendo, inclusive, abusiva cláusula que exclua a cobertura de fármacos de uso domiciliar, conforme se preceitua no art. 51, IV, e no art. 51, § 1º, II, ambos do Código de Defesa do Consumidor. [...] **Reconhecendo-se o dever de cobertura, igualmente é devido à demandante a restituição, a título de danos materiais, das despesas com a aquisição do fármaco devidamente comprovadas**. Sucumbência redistribuída. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082352014, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-08-2019) (grifei)*

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, a incidência de percentual sobre o valor da causa (R$ 840,67) e sobre o proveito econômico implicaria horários irrisórios. Assim, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

Pelo exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** a ação ajuizada por JANE FERRAZ GOMEScontra UNIMED VALE DO SINOS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA para:

a) confirmar em parte a tutela de urgência e condenar a ré à obrigação de fazer consistente no fornecimento e aplicação do medicamento Prolia/Denosumabe, uma ampola de seis em seis meses, como descrito no laudo médico, enquanto perdurar a necessidade;

b) condenar a ré a ressarcir R$ 840,67, corrigidos monetariamente pelo IPCA a contar do desembolso e, a partir da citação, acrescidos de juros de mora e corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (que já abarca correção monetária - art. 389, parágrafo único e art. 406, §1.º, do Código Civil).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador da autora, que fixo em R$ 1.300,00, com correção monetária pelo IPCA a contar desta data e juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA (art. 406, §1º, do CC), a contar do trânsito em julgado.

Interposto recurso de apelação, observando-se o artigo 1.010, §1° do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. No caso de haver recurso adesivo, intime-se a parte apelada para contrarrazões no mesmo prazo. Após, subam os autos imediatamente ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Havendo custas pendentes, adotem-se as providências de praxe.

Com o trânsito em julgado, e tudo atendido, baixe-se.

Agendada a intimação das partes. Publicação e registro eletrônicos. **Intime-se a parte ré no DJE.**

Documento assinado eletronicamente por **VANESSA CALDIM DOS SANTOS, Juíza de Direito**, em 31/01/2025, às 19:12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10075782338v26** e o código CRC **cb9cdfa8**.